MODELO DE PLANIFICACIÓN

PARA EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE GESTION DE TECNOLOGIAS MEDICAS EN LA COMUNIDAD INDIGENA PURÉPECHA DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

Ing. Martha Paola Vázquez Espino, Instituto Tecnológico Superior P'urhépecha



OBJETIVOS

Objetivo general
Desarrollar un modelo local de gestión de tecnología médica en Nahuatzen para contribuir al acceso equitativo a los servicios de salud.

Objetivos específicos
- Mejorar la disponibilidad real del equipo mediante mantenimiento.
- Capacitar al personal en el uso y mantenimiento de equipos médicos y de laboratorio.
- Evaluar cambios en la atención y entrega de resultados para favorecer el acceso equitativo a la salud.

INTRODUCCIÓN

La disponibilidad real de equipos y la capacitación del personal son relevantes para sostener los servicios de salud en comunidades indígenas. Las fallas pueden interrumpir la atención y limitar la capacidad del centro. La OMS (2011) propone inspección y mantenimiento preventivo y correctivo; su guía de 2025 integra inventarios, capacitación y sistemas digitales de seguimiento [1, 2].

El aporte de este proyecto es adaptar estos principios al Centro de Salud de Nahuatzen mediante evaluación del equipamiento, mantenimiento y capacitación. La colaboración descrita corresponde al personal sanitario y las autoridades locales en tareas de coordinación. Su contribución radica en esta aplicación contextualizada en la Meseta Purépecha y en documentar cambios en la disponibilidad del equipo y los servicios, sin asumir ausencia de estudios previos.

PARTICIPANTES

Personal participante
Personal médico, de atención y de laboratorio del Centro de Salud de Nahuatzen.

Capacitación y evaluación
Personal capacitado en el uso y mantenimiento del equipo; se reportó una encuesta a un profesional de laboratorio. El total de asistentes requiere cotejo.

Coordinación local
Colaboración con autoridades locales. La intervención descrita se centra en el personal sanitario.

No se evaluó directamente a pacientes.

METODOLOGÍA

Enfoque y diseño
Estudio de intervención con enfoque mixto y comparación descriptiva antes-después, sin grupo de control.
Ámbito y participantes
Centro de Salud de Nahuatzen: personal médico, de atención y de laboratorio, en coordinación con autoridades comunitarias.
Intervención
Evaluación del equipamiento, mantenimiento preventivo y correctivo, y capacitación en el uso adecuado del equipo y en ambos tipos de mantenimiento.
Recolección de datos
Registros del estado de los equipos, actividades realizadas, encuestas al personal y cifras de atención antes y después.
Análisis
Cantidades y porcentajes para los datos cuantitativos; identificación de temas en respuestas abiertas para el componente cualitativo.

RESULTADOS

Seguimiento: una semana, según la observación recibida; duración por confirmar.

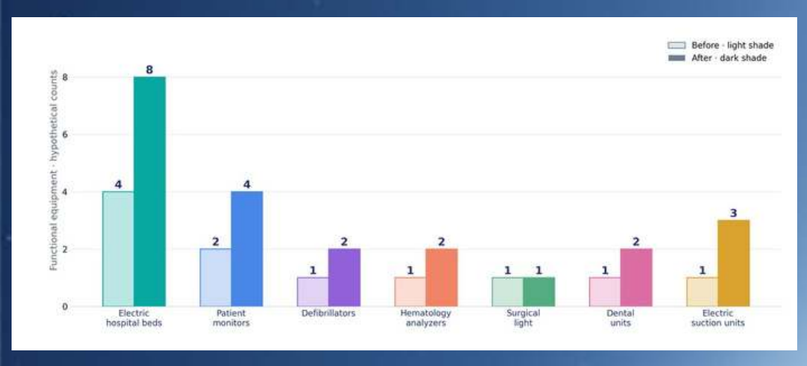
LABORATORIO
5 → 10
Pacientes por jornada reportada (+100 %).

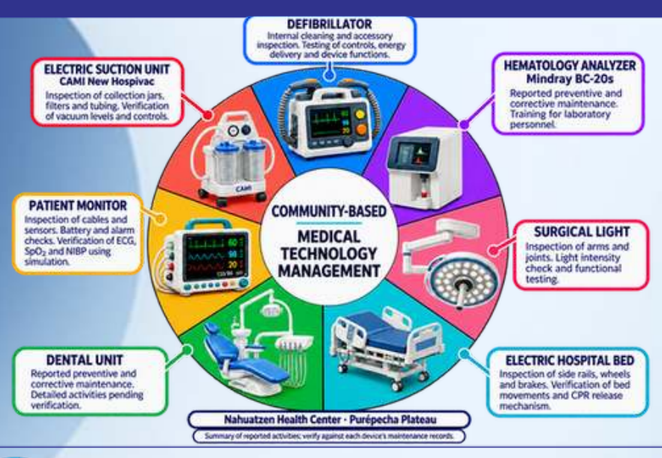
ODONTOLOGÍA
8 → 16
Fichas disponibles (+100 %). Confirmar si corresponden a citas.

CAPACITACIÓN
Uso y cuidado
Uso, mantenimiento preventivo y correctivo. Asistentes por confirmar.

ENCUESTA
1 profesional
Reportó satisfacción y mayor rapidez diagnóstica percibida.

EQUIPAMIENTO: ANTES Y DESPUÉS









CONCLUSIONES

La gestión de tecnología médica en Nahuatzen integra mantenimiento, capacitación del personal y coordinación con autoridades locales para fortalecer la disponibilidad real del equipo. Se reportaron aumentos en pacientes atendidos en laboratorio y fichas disponibles en odontología. Sin embargo, falta precisar el significado de estas fichas y documentar cómo la disponibilidad del equipo o los cambios en el servicio se relacionaron con su incremento; no puede atribuirse este resultado a la capacitación por sí sola. Dar continuidad al registro de fallas, mantenimiento y atención permitirá valorar la sostenibilidad del modelo y su contribución al acceso a los servicios de salud.

REFLEXIONES TECNOLÓGICAS

Aprendizajes del verano y propuestas de continuidad

La tecnología requiere gestión

La experiencia muestra que disponer de equipos debe acompañarse de mantenimiento, capacitación y coordinación local. El aprendizaje del verano es que la utilidad de la tecnología depende también de cómo se organiza y sostiene su uso.

Herramientas para dar continuidad

Se propone un inventario digital con bitácoras de fallas, responsables y fechas de mantenimiento. Recordatorios automáticos y registros de atención permitirían dar seguimiento a equipos y servicios. Estas herramientas son propuestas; no se reportan como implementadas.

Capacitación accesible y pertinente

Se proponen videos breves y guías de consulta, disponibles sin conexión y adaptadas al contexto lingüístico del personal. El apoyo técnico a distancia puede complementar la capacitación. Su aplicación requiere recursos, protección de datos y evaluación periódica.

Alcance de los resultados: los cambios reportados describen la experiencia local. Con la duración de seguimiento pendiente de confirmar y sin grupo de comparación, no permiten atribuir por sí solos las mejoras a la intervención.

REFERENCIAS

[1] Organización Mundial de la Salud. (2011). Medical equipment maintenance programme overview. https://www.who.int/publications/i/item/9789241501538

[2] Organización Mundial de la Salud. (2025). Inventory and maintenance management information system for medical devices. https://www.who.int/publications/i/item/9789240111257

Autora: Ing. Martha Paola Vázquez Espino | **Mentor:** Betzael | **Co-mentora:** Edna Marlene